

EVAKUIERUNGSPLAN & GEFAHREN-SOP

FEUERWEHR / RETTUNG 112

Häusliche 1:1-Intensivpflege & Beatmung (§ 132I SGB V / § 29 SGB IX)

24/7 Notrufzentrale

1. KLIENTEN- & STANDORT-PASS (NOTFALL-STAMMDATEN)

Klient / Patient:		Geburtsdatum:	____.____.19____
Versorgungsadresse:	Hohenfelsstraße 34, 35232 Dautphetal	Pflegegrad / Status:	PG ____ 1:1 AKI Beatmung
Trachealkanüle / Cuff:	Größe: ____ Typ: ____ Cuff: ____ mmHg	Beatmungsmodus:	Invasiv [] / NIV [] Pcontrol/PSV
Sauerstoff / O2-Flow:	____ l/Min (Konzentrator + O2-Flasche)	Patientenverfügung:	DNR [] DNI [] Volltherapie []
24/7 Angehörigenkontakt:	Name: ____ Tel: ____	AERIS Leitung (René Krieg):	Tel: 0170 / ____

2. DER 5-SCHRITTE EVAKUIERUNGS-ALGORITHMUS (SOP AM INTENSIVBETT)

SCHRITT 1	ATEMWEG & BEATMUNG SICHERN (LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHME) • Beatmung umstellen: Beatmungsgerät auf Akkubetrieb trennen ODER sofort auf manuellen Beatmungsbeutel (Ambu-Beutel) mit O2-Reservoir und O2-Flasche umkoppeln. • Tracheostoma prüfen: Freigängigkeit der Kanüle sichern, ggf. 1x tief absaugen (-0.2 bar). Cuff-Druck kontrollieren. • Absaugung sichern: Akkubetriebenes Notfall-Absauggerät einschalten und am Transport-Rollstuhl/Pflegebett fixieren.
SCHRITT 2	NOTRUF 112 & SPEZIAL-ALARMIRUNG RETTUNGSLEITSTELLE • Gezielte Meldung an Leitstelle: 'Evakuierung eines intensivpflichtigen, beatmeten Patienten mit Tracheostoma!' • Gefahrenart nennen: Brand / Rauchentwicklung / Wasserschaden / Unbewohnbarkeit / Stromausfall. • Ressourcen anfordern: Notarzt, Rettungswagen (RTW) / Intensivtransportwagen (ITW) und Feuerwehr mit Rettungstuch.
SCHRITT 3	PERSONENRETTUNG & EVAKUIERUNGSWEG (AUS DEM GEFAHRENBEREICH) • Fluchtweg wählen: Primär barrierefreier Erdgeschoss-Ausgang / Haustür. Bei Verqualmung: Türen schließen, am Boden bleiben. • Transportmittel nutzen: 1) Elektrischer/Manueller Aktiv-Rollstuhl ODER 2) Rettungstuch / Evakuierungsmatratze ODER 3) Pflegebett rollen (wenn ebenerdig). • Rauchschutz: Patient und Pflegekraft feuchte Tücher über Mund/Nase legen. Niemals Aufzüge benutzen!
SCHRITT 4	MITNAHME BETHNAHE EVAKUIERUNGSTASCHE (NOTFALLGEPÄCK) • Bettnahe Notfalltasche greifen: Ersatzkanülen (Original + 1 Nr. kleiner), Stomaspreizer, NaCl 0.9 %, Beatmungsbeutel. • Medikamente & Dokumente: Notfall-Medikamentenbox, Klienten-Notfallpass, Patientenverfügung, Dienstplan/Doku-Satz. • Sauerstoff-Reserve: Leichtbau-Transport-Sauerstoffflasche mit Druckminderer.
SCHRITT 5	SAMMELPLATZ, ÜBERGABE & AERIS NOTFALLKETTE • Sammelplatz anfahren: Windgeschützter, sicherer Bereich außerhalb der Gefahrenzone (z.B. Nachbarhaus / RTW). • Strukturierte Übergabe (ISBAR): Lückenlose Übergabe des Beatmungstatus an Notarzt / Einsatzleiter Feuerwehr. • AERIS-Leitung informieren: Umgehend Inhaber René Krieg informieren zur Aktivierung des Ausfall- & Springerpools.

3. CHECKLISTE: BETTNAHE EVAKUIERUNGS- & TRANSPORTAUSRÜSTUNG

Die bettnahe Evakuierungstasche muss in der 1:1-Intensivpflege zu jedem Zeitpunkt griffbereit und vollständig bestückt direkt neben dem Pflegebett gelagert werden (§ 12 MPBetreibV).

Kategorie	Erforderliches Notfall- & Evakuierungs-Equipment	Prüfstatus
Atemwegs-Management	• 1x Ersatz-Trachealkanüle (Originalgröße & passende Charge) • 1x Ersatz-Trachealkanüle (1 Nummer kleiner für schwierigen Wechsel) • 1x Tracheostoma-Spreizer (Laborde-Spreizer) & Guedel-Tubus • 1x Kanülentrageband, Kompressen, Y-Mullkompressen, Stomaöl/Gleitgel	☐ Vollständig ☐ Einsatzbereit
Beatmung & O2	• 1x Beatmungsbeutel (Ambu-Beutel) mit PEEP-Ventil & O2-Reservoir • 1x Mobile Leichtbau-Sauerstoffflasche (mind. 200 bar, gefüllt) • 1x Mobiles Transport-Beatmungsgerät (oder Akku-Hauptgerät > 4 Std. Akku) • Ersatz-Schlauchsysteme, HME-Filter (Künstliche Nase), Gurgelwinkel	☐ Vollständig ☐ Akku > 80 %
Absaugung & Pflege	• 1x Akkubetriebene Notfall-Absaugpumpe (z.B. Accuvac / Vacoset) • 10x Atraumatische Absaugkatheter (passende Charrière-Größe) • 10x NaCl 0.9 % Ampullen (5 ml / 10 ml) zur Instillation / Sekretlösung • Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Abwurfbeutel	☐ Vollständig ☐ Geprüft
Notfallgepäck & Doku	• AERIS Notfall- & Evakuierungsmappe (Klientenpass, Behandlungsplan) • Ausgewiesene Notfall-Medikamentenbox (Analgetika, Bronchodilatoren) • Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht / DNR-DNI Statusblatt • Mobiltelefon der Pflegekraft mit Ladekabel / Powerbank	☐ Griffbereit ☐ Aktualisiert

4. HANDLUNGSANWEISUNGEN FÜR SPEZIFISCHE GEFAHRENSZENARIEN

SZENARIO A: BRAND / GEFÄHRLICHE RAUCHENTWICKLUNG 1. Sofortige Rettung: Patient umgehend aus dem verqualmten Zimmer evakuieren. 2. Türen schließen: Brandzimmer-Tür schließen, um Rauchausbreitung zu stoppen. 3. Rauchschutz: Feuchtes Tuch vor Tracheostoma/Kanülenfilter legen. 4. Notruf 112: Standort, Brandort, intensivpflichtigen Patienten melden. 5. Kein Aufzug: Nur Treppen/Rampe nutzen. Rettungstuch einsetzen.	SZENARIO B: FLÄCHENDECKENDER STROMAUSFALL (> 2 STUNDEN) 1. Akkubetrieb prüfen: Beatmungsgerät & Absaugung schalten automatisch auf Akku (> 4h). 2. Notstrom / Aggregat: Externen Zusatzakku / Powerstation / Generator zuschalten. 3. Manuelle Reserve: Ambu-Beutel & O2-Flasche druckbereit neben das Bett stellen. 4. EVU / Leitstelle: Energieversorger & Leitstelle (112) über Beatmungspatient informieren. 5. Evakuierung vorbereiten: Bei Akku < 30 % Evakuierung in Klinik einleiten.
SZENARIO C: AKUTER GASGERUCH / GEBÄUDESCHADEN 1. Keine Funkenbildung: Lichtschalter, Handys & Schalter NICHT betätigen! 2. Fenster öffnen: Sofort Stoßlüften, sofern gefahrlos möglich. 3. Hauptgashahn: Hauptgashahn/Absperrventil im Keller/Haus schließen. 4. Sofortige Evakuierung: Patient ins Freie bringen & 112 aus Distanz anrufen.	SZENARIO D: UNVORHERGESEHENER SCHICHTAUSFALL (KEIN ERSATZ) 1. Keine Dienstverlassung: Patient darf NIEMALS unbeaufsichtigt bleiben! 2. Angehörigen-Deal aktivieren: Geschulte Angehörige für Erstüberbrückung (2-4h) einbinden. 3. AERIS-Rufbereitschaft: René Krieg / PDL-Notrufnummer zur Springer-Gestellung kontaktieren. 4. Klinikeinweisung: Wenn nach 4h kein Ersatz möglich: Notfall-Einweisung über 112.

5. GEBÄUDE- & EVAKUIERUNGSPLAN-SKIZZE (STANDORT DAUTPHETAL)

FLUCHT- & EVAKUIERUNGSWEGE IM PRIVATEIGENHEIM DAUTPHETAL

• PRIMÄRER EVAKUIERUNGSWEG (ERDGESCHOSS / INTENSIVZIMMER):

Pflegebett / Rollstuhl → Zimmertür → Flur Erdgeschoss → Hauptausgang / Haustür → Vorplatz / Sammelplatz A (Strasse).

• SEKUNDÄRER EVAKUIERUNGSWEG (ALTERNATIV-AUSGANG):

Pflegebett / Rollstuhl → Terrassentür Intensivzimmer → Garten / Barrierefreie Rampe → Sammelplatz B (Gartentor).

• **BARRIEREFREIHEIT:** Stufenfreier Zugang über Terrassentür vorhanden. Breites Ausfalltor für RTW-Trage geeignet.

WICHTIGE SCHALTEINRICHTUNGEN IM HAUS:

• **Hauptstrom-Sicherungskasten:** ☐ Flur / Erdgeschoss | ☐ Kellerraum 1

• **Hauptgashahn / Absperrventil:** ☐ Außenwand / Hausanschlussraum

• **Hauptwasser-Absperrhahn:** ☐ Hausanschlussraum Keller

6. NOTFALLKONTAKT- & ALARMIERUNGSREGISTER (RETTUNGSKETTE)

Institution / Ansprechpartner	Funktion / Spezifikation	Telefonnummer / Erreichbarkeit
Feuerwehr / Rettungsdienst	Notruf & Qualifizierte Leitstelle Marburg-Biedenkopf	112 (24 Std. gebührenfrei)
Polizeidienststelle Biedenkopf	Regionale Polizeipressestelle / Einsatzleitung	110 / 06461 / 929-0
AERIS Pflegedienstleitung	René Krieg (Inhaber & AKI-Fachkraft)	0170 / _____ (24/7 Rufbereitschaft)
UKGM Wund- & Weaningzentrum	Universitätsklinikum Marburg (Intensivstation)	06421 / 58-0 (Zentrale)
Medizintechnik-Provider (24/7)	Geräte-Service Beatmung & Absaugung (MPBetreibV)	0800 / _____ (24h Hotline)
Behandelnder Hausarzt	Praxis Hausarzt Dautphetal / Gladenbach	Tel: _____
Energieversorger (EAM / Netz)	Strom- & Gas-Entstördienst Marburg-Biedenkopf	0800 / 3252525 (24h Störungsdienst)

7. UNTERWEISUNG & FORMELLER BESTÄTIGUNGSVERMERK

Hiermit wird bestätigt, dass das eingesetzte Intensivpflege-Team sowie der Klient / die Angehörigen am Standort Dautphetal anhand dieses Evakuierungsplanes und der Notfall-SOPs am Intensivbett unterwiesen wurden.

Dautphetal, den _____

Dautphetal, den _____

Dautphetal, den _____

Unterschrift Klient / Gesetzl. Betreuer

Unterschrift Diensthabende Pflegekraft

René Krieg (AERIS Inhaber / PDL)